

Informe de Evaluación: Planeación de la Mejora Continua (PMC) 2025–2026

Plantel: Bachillerato General Oficial "Moisés Sáenz Garza" (CCT 21EBH0465E) **Evaluador:** Ing. Samuel Cruz Interrial

1. Resumen Ejecutivo

El documento presentado se clasifica como **parcialmente completo**. El plantel demuestra una **fortaleza significativa en el uso de indicadores cuantitativos** dentro de su diagnóstico y metas, alineándose con la metodología basada en datos. Sin embargo, el PMC presenta un **bloqueo normativo crítico** en la columna de "Evidencias", donde se enlistan masivamente elementos no válidos (fotografías, minutas, videos) según las instrucciones de llenado. Además, existen incoherencias numéricas entre la narrativa del diagnóstico y las tablas de metas que deben depurarse.

2. Resultados de la Lista de Cotejo

Evaluación basada en la *Lista de cotejo del PMC* y los *Lineamientos*.

Componente	Estado	Evidencia / Observaciones	Recomendación Técnica
1. Portada	Cumple	Datos completos, CCT y logos oficiales presentes.	Ninguna.
2. Contenido	Cumple	Índice ordenado y paginado.	Ninguna.
3. Presentación	Cumple	Misión, Visión y Valores definidos.	Ninguna.
4. Normativa	Cumple	Cita leyes y acuerdos (442, 444, 447) correctamente.	Correcto.
5. Diagnóstico	Cumple Parcialmente	Incluye datos duros (aprobación 100%, abandono 4.2%). Falla: Inconsistencia de datos (ver análisis abajo).	Unificar cifras de abandono (4.2% vs 5%).
6. Priorización	Cumple	Ordena las 3 categorías obligatorias.	Correcto.
7. Plan de Acción	No Cumple	Estructura correcta, pero las evidencias violan la normativa explícita . Se proponen "Fotografías", "Minutas".	Sustituir por reportes analíticos.
8. Participación	Cumple	Firmas de docentes, alumnos y supervisor.	Correcto.

3. Aspectos Clave de Análisis (Prioritarios)

A. Diagnóstico del Plantel

- **Fortaleza:** El diagnóstico utiliza indicadores académicos precisos. Cita textualmente: "*índice de aprobación... fue del 100%*", "*deserción total fue de 4.2%*". Esto facilita la creación de metas medibles.
- **Inconsistencia de Datos (Error Técnico):**
 - En la narrativa (pág. 9) afirma que el abandono fue del **4.2%**.
 - En la tabla de metas (pág. 12) afirma que se registró un **5%** de abandono.
 - *Acción:* Se debe homologar el dato para establecer una línea base real y confiable.

B. Evaluación de Metas (Criterio SMART)

Se analizan metas representativas bajo los criterios de las *Instrucciones de llenado*.

Meta 1 (Académica - Abandono): "*Disminuir el abandono escolar del 5% al 3%*".

- **Clasificación: b) Implementable con ajustes menores.**
- **Análisis:** Es Específica, Medible, Relevante y Temporal. El ajuste necesario es corregir la línea base (¿es 5% o 4.2% según el diagnóstico?).

Meta 2 (Académica - Rendimiento): "*Mejorar el rendimiento académico... del 65% al 78%*".

- **Clasificación: a) Implementable sin ajustes.**
- **Análisis:** Excelente formulación. Define la situación actual (65%) y la deseada (78%), permitiendo una evaluación objetiva.

Meta 3 (PEC): "*Continuar con el Ballet Escolar y realizar limpia... de árboles*".

- **Clasificación: c) No implementable (requiere replanteamiento).**
- **Justificación:** "Continuar" es una actividad, no un resultado de mejora. No es Medible en términos de impacto educativo o comunitario.
- **Ajuste:** "Lograr la participación del X% de la comunidad en las jornadas de limpieza..." o "Incrementar en un X% los estudiantes inscritos en actividades artísticas".

Meta 4 (Violencia): "*Disminuir la violencia escolar de un 5% a un 2%*".

- **Clasificación: a) Implementable sin ajustes.**
- **Análisis:** Asigna un porcentaje al fenómeno de violencia, lo cual es retador pero metodológicamente correcto para medir avance.

C. Estrategias de Implementación

- **Pertinencia:** Las estrategias son operativas y claras (monitoreo por WhatsApp, visitas domiciliarias, rúbricas).
- **Clasificación Errónea:** La meta de "**Consumo de alcohol**" está ubicada en la **Categoría 2 (Gestión)**. Por su naturaleza preventiva y de salud, pertenece normativamente a la **Categoría 3 (Socioemocional)**. Debe moverse.

D. Responsables y Entregables (Falla Crítica)

- **Responsables:** Claramente definidos (Director, Docentes, Asesor de grupo).
- **Entregables (Incumplimiento Normativo):** El documento lista reiteradamente:
 - "*Minuta de acuerdo*".
 - "*Fotografía*".

- "Fotografías y videos".
- **Normativa:** Las *Instrucciones de llenado* establecen textualmente: "**no serán válidas evidencias tales como listas, minutas, fotografías u otros elementos que no estén acompañados de un análisis descriptivo**".
- **Acción Correctiva:** Se deben reemplazar por "Informe de seguimiento al abandono", "Reporte de resultados de evaluación diagnóstica", "Análisis de incidencias de violencia".

E. Seguimiento y Viabilidad

- **Cronograma:** Establece fechas específicas (ej. "29 de septiembre de 2025") y periodos ("Los tres últimos días de cada mes"), lo cual favorece el seguimiento puntual.
- **Factibilidad:** Las metas son realistas. Bajar el abandono del 5% al 3% o la violencia del 5% al 2% son objetivos alcanzables mediante las estrategias de tutoría y monitoreo propuestas.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Principales Fortalezas

1. **Cultura de Datos:** El plantel tiene claro sus números (aprobación, deserción, promedios). Esto es una ventaja competitiva para la gestión directiva.
2. **Enfoque Preventivo:** Atiende problemáticas reales y graves detectadas en el diagnóstico (alcoholismo, violencia) con metas porcentuales específicas.
3. **Cronograma Detallado:** A diferencia de otros planteles que usan "Permanente" para todo, este PMC define fechas de corte específicas.

Áreas de Oportunidad Críticas

1. **Evidencias No Válidas:** El uso de fotos y minutas como evidencia de cumplimiento invalida técnicamente el reporte de resultados según los lineamientos.
2. **Inconsistencia Numérica:** La discrepancia entre el 4.2% y el 5% de abandono resta seriedad al diagnóstico.
3. **Clasificación de Categorías:** La prevención de adicciones debe moverse a la Categoría 3.

Respuestas Explícitas

¿El PMC cumple al 100% con los lineamientos? No. Cumple aproximadamente al 75%. Tiene una estructura sólida y buenos datos, pero falla en el cumplimiento técnico de los "Entregables" y en la clasificación de algunas metas por categoría.

¿Qué ajustes son indispensables para su validación?

1. **Sustitución de Evidencias:** Cambiar en todas las tablas "Fotografías/Minutas" por "**Informes**", "**Reportes de análisis**" o "**Actas de evaluación de resultados**".
2. **Corrección de Datos:** Unificar el porcentaje de abandono (elegir 4.2% o 5%) en todo el documento.
3. **Reubicación de Meta:** Mover la meta de "Consumo de alcohol" de Gestión a Desarrollo Socioemocional.

¿El PMC es viable para su implementación? Sí, es altamente viable. Las estrategias propuestas (uso de WhatsApp, visitas, pláticas con sector salud) son de bajo costo y alto impacto potencial. El personal está asignado y las fechas son claras. Con los ajustes de forma documental, será un excelente instrumento rector.

A. Preguntas de estado general del PMC

1. ¿El PMC está completo conforme a los lineamientos y la lista de cotejo o presenta omisiones críticas? El PMC está estructuralmente completo pero presenta **omisiones técnicas críticas** en la validación normativa de sus evidencias. Aunque cubre los apartados requeridos (Diagnóstico, Categorías, Metas, Cronograma), incumple la instrucción explícita de no usar fotografías o listas como evidencia única,.

2. ¿El PMC cumple al 100 % con los criterios obligatorios o qué porcentaje real de cumplimiento tiene? Tiene un cumplimiento real estimado del 75 %.

- **Cumple:** Diagnóstico con datos duros, alineación a las 3 categorías y cronogramas con fechas específicas.
- **No Cumple:** Validez de los productos entregables (usa evidencias prohibidas) y clasificación correcta de todas las metas (una meta de salud está en la categoría de gestión).

3. ¿El PMC puede validarse tal como está o requiere ajustes previos obligatorios? Requiere ajustes previos obligatorios. No se puede validar un documento institucional que presenta "Fotografías" y "Minutas" como evidencia de logro académico, ya que esto contraviene las instrucciones de llenado que exigen análisis descriptivo.

B. Preguntas sobre la calidad de las metas

4. ¿Todas las metas están correctamente formuladas (verbo de acción, plazo, indicador, cantidad/porcentaje y evaluación)? En su mayoría, sí. El plantel destaca por usar porcentajes claros basados en su historial (ej. "Mejorar el rendimiento... del 65% al 78%"). Esto cumple con el criterio SMART (Medible y Específico).

5. ¿Qué metas cumplen completamente con los criterios mínimos y pueden implementarse sin ajustes?

- **Meta de Rendimiento Académico:** "Mejorar el rendimiento académico... del 65% al 78%". Es ejemplar: tiene línea base, meta numérica, y fecha de corte.
- **Meta de Violencia:** "Disminuir la violencia escolar de un 5% a un 2%".

6. ¿Qué metas cumplen parcialmente y qué elementos específicos deben corregirse?

- **Meta de Abandono Escolar:** Cumple parcialmente. Se debe corregir la **inconsistencia de datos**: el diagnóstico narrativo dice 4.2%, pero la tabla de la meta dice 5%.
- **Meta de Alcoholismo:** Cumple parcialmente. Debe corregirse su **ubicación**; está en la Categoría 2 (Gestión), pero pertenece a la Categoría 3 (Socioemocional/Salud).

7. ¿Qué metas NO pueden considerarse válidas y deben replantearse desde cero? ¿Por qué?

- **"Continuar con el Ballet Escolar y realizar limpia..."**.
 - *Por qué:* "Continuar" no es una meta de mejora, es una actividad de mantenimiento. Además, mezcla dos temas distintos (arte y limpieza). Debe replantearse como: "Lograr la participación del X% de alumnos en actividades artísticas" o "Realizar 3 campañas de limpieza con participación comunitaria".
-

C. Preguntas sobre estrategias y acciones

8. ¿Las acciones específicas propuestas realmente permiten alcanzar cada meta o solo la describen? Las acciones son operativas y directas. Estrategias como el "monitoreo de alumnos que no asistan a clases día a día" vía WhatsApp son acciones concretas que inciden directamente en la reducción del abandono.

9. ¿Qué acciones son viables con los recursos, tiempos y personal del plantel? La gran mayoría son altamente viables. El uso de recursos tecnológicos propios (celulares, redes sociales) y la gestión con el centro de salud local no implican costos adicionales y aprovechan el capital relacional del plantel.

10. ¿Qué acciones no son viables o no guardan relación directa con la meta que pretenden atender? La acción de "Gestionar... la construcción de una cancha... y cisterna" es necesaria, pero si la meta de "Gestión" depende al 100% de la respuesta de una autoridad externa (Ayuntamiento/Estado), la viabilidad de *cumplimiento* es baja. Se sugiere acotar la meta a la *gestión del expediente* y no a la *construcción* final, que no depende del director.

11. ¿Existen acciones que deberían eliminarse o sustituirse porque no cumplen con los lineamientos? Sí. Deben eliminarse las acciones centradas únicamente en la recolección de evidencia burocrática, como "Obtener evidencias de las actividades realizadas (fotografía)". La acción debe ser el análisis pedagógico, no la foto.

D. Preguntas sobre evaluación y seguimiento

12. ¿Cada meta cuenta con un proceso de evaluación claro, medible y verificable? El proceso de *cronograma* es claro (fechas específicas), pero el instrumento de *verificación* es deficiente. Verificar una meta educativa con una "Minuta de acuerdo" o "Fotografía" no permite medir el impacto real en el aprendizaje.

13. ¿Los productos/entregables propuestos son válidos según los lineamientos o requieren ajuste? Requieren ajuste total. El documento propone sistemáticamente: "Minuta", "Fotografía", "Lista", "Video".

- **Normativa:** Las instrucciones establecen explícitamente: "no serán válidas evidencias tales como listas, minutas, fotografías u otros elementos que no estén acompañados de un análisis descriptivo".

14. ¿El seguimiento propuesto permite saber si la meta se cumplió o no al final del ciclo escolar? Sí, porque establecieron métricas numéricas claras (del 5% al 3%). Aunque la evidencia documental propuesta sea débil, el indicador numérico permitirá saber al final si se logró o no.

E. Preguntas sobre coherencia interna

15. ¿Existe coherencia entre diagnóstico, meta, acciones, productos y evaluación en cada categoría? Alta Coherencia Numérica. El diagnóstico dice: "reprobación... fue del 100%... deserción total fue de 4.2%". Las metas responden a esos números. Esta alineación basada en datos es una gran fortaleza del plantel.

16. ¿Qué categoría o subcategoría presenta la mayor debilidad estructural y por qué? Categoría 2 (Gestión y Administración).

- **Por qué:** Contiene una meta mal clasificada ("Consumo de alcohol") que debería estar en la Categoría 3. Esto denota una confusión conceptual sobre los ámbitos de gestión vs. desarrollo socioemocional.
-

F. Preguntas de viabilidad real

17. ¿El PMC es viable de implementarse durante el ciclo 2025–2026 con las condiciones reales del plantel? Sí, es muy viable. Es un plan realista que ataca problemas básicos (asistencia, operaciones matemáticas, violencia) con recursos disponibles. No promete imposibles.

18. ¿Qué riesgos podrían impedir el cumplimiento de las metas y cómo podrían mitigarse?

- *Riesgo*: La "Poca participación de los padres" detectada en el FODA.
- *Mitigación*: Fortalecer las estrategias de comunicación (WhatsApp) que ya proponen, pero formalizando los compromisos con "Cartas compromiso" en lugar de solo pláticas.

19. ¿Qué metas conviene implementar de inmediato y cuáles requieren ajustes antes de iniciar?

- *De inmediato*: Las metas académicas de regularización en operaciones básicas (tienen fechas en septiembre/octubre).
- *Ajustar antes*: La meta del **Ballet Escolar/Limpieza**. Debe redefinirse para que sea una meta de formación integral medible y no solo una actividad continua.

G. Preguntas orientadas a la máxima puntuación

20. ¿Qué tendría que corregirse para que el PMC alcance la máxima puntuación posible?

1. **Sustitución de Evidencias**: Cambiar "Fotografías/Minutas" por "Informes de Resultados" y "Reportes de Análisis" en todas las tablas.
2. **Corrección de Datos**: Unificar el dato de abandono (4.2% o 5%) para evitar contradicciones.
3. **Reclasificación**: Mover la meta de alcoholismo a la Categoría 3.

21. ¿Qué ajustes son de alto impacto y cuáles son solo de forma?

- *Alto Impacto*: La validación de evidencias. Esto transforma el PMC de un álbum de fotos a un instrumento de gestión directiva basado en análisis.
- *De Forma*: Corregir la ubicación de la meta de alcoholismo en el documento.

22. Si se aplican todas las recomendaciones, ¿el PMC quedaría plenamente alineado a los lineamientos? **Sí**. El plantel tiene lo más difícil: cultura de datos y fechas precisas. Con los ajustes técnicos en los entregables, sería un PMC modelo.

Pregunta de cierre ejecutivo (clave)

23. ¿Qué le falta a este PMC para ser un plan sólido, viable y completamente alineado a los lineamientos oficiales? Le falta **formalizar los entregables sustituyendo la evidencia visual (fotos) por evidencia analítica (reportes) y corregir la inconsistencia numérica del diagnóstico** para asegurar la precisión de las metas.